

# O funil da WinDoc não tem meio

Base de conhecimento, engenharia de prompt e documento de decisão gerado por IA para um problema real de captação e conversão.

**Tese.** A WinDoc não tem problema de audiência: a meta de topo de funil já planejada é de 4 a 7 vezes maior do que o necessário para as duas turmas do ano. O valor vaza no meio — um salto de R\$ 0 para R\$ 60.000 sem degrau intermediário, nenhuma das oito etapas do funil medida, e o melhor instrumento de vendas da empresa sendo usado como formulário de cadastro.

---

**Aluno:** Dr. Fernando Jorge

**Empresa analisada:** WinDoc — Escola de Empreendedorismo e Empresarização Médica

**Ferramenta exigida:** Claude Code (arquivos criados em sessão de terminal)

**Repositório público:** [github.com/DrFernandoJorge/Fernando-Jorge](https://github.com/DrFernandoJorge/Fernando-Jorge) — branch `claude/mba-ai-task-oxmj7g`, diretório `mba/`

**Data:** setembro de 2026

# Conteúdo

O enunciado pediu três arquivos de base de conhecimento criados no Claude Code, um prompt construído a partir deles e a resposta gerada. As seções 1 a 3 são a base; as seções 4 e 5 são a entrega. O anexo mostra o desdobramento operacional da resposta.

|   |                                      |                  |
|---|--------------------------------------|------------------|
| 1 | O problema: captação e conversão     | problema.md      |
| 2 | O negócio: como a WinDoc atua hoje   | negocio.md       |
| 3 | O cliente: ICP e personas            | cliente.md       |
| 4 | Entrega 1 — o prompt                 | prompt.md        |
| 5 | Entrega 2 — a resposta gerada        | resposta.md      |
| A | Anexo — plano de execução de 90 dias | plano-de-acao.md |

**Como ler os números deste documento.** Os dados do negócio são hoje parcialmente estimados. Quando isso acontece, o risco não é a IA errar — é a IA acertar com confiança falsa. Por isso cada número carrega a sua origem:

**[D] documentado** — existe em material interno ou público da empresa.

**[E] estimativa do fundador** — número de cabeça, não validado por sistema.

**[P] premissa da IA** — valor que a análise precisou assumir; declarado e falseável, com caminho explícito de validação.

Essa convenção é a principal decisão de engenharia de prompt do trabalho, e está justificada na Parte II da seção 4.

# O problema: captação e conversão

problema.md

Base de conhecimento nº 2 de 3. Estrutura exigida: **(a)** qual o problema · **(b)** como é hoje · **(c)** quem sofre · **(d)** o que muda se resolver · **(e)** que dados são necessários. Convenção: **[D]** documentado · **[E]** estimativa a validar.

## (a) Qual é o problema

**A WinDoc tem oferta de alto valor, autoridade real e método proprietário — mas não tem um sistema de aquisição e conversão. A venda depende de esforço manual do fundador, não é medida em nenhuma etapa, e por isso não é previsível nem escalável.**

O problema tem três camadas, nesta ordem de gravidade:

1. **Camada de oferta (estratégia).** A esteira salta de *conteúdo gratuito* direto para *R\$ 60.000 / 12 meses*. Não existe degrau intermediário pago que transforme audiência em cliente pagante, qualificado e aquecido. Um médico que acabou de descobrir o perfil só tem duas opções: consumir de graça para sempre, ou assumir o maior compromisso de desenvolvimento profissional da carreira dele. [D/E]
2. **Camada de meio de funil (plano).** Não há CRM, não há etapas nomeadas, não há SLA de resposta, não há cadência de follow-up e não há dono do processo. O lead que não fecha na primeira conversa simplesmente desaparece. [D]
3. **Camada de execução (ação).** Toda a operação comercial — responder DM, qualificar, agendar, diagnosticar, propor, dar follow-up — está na mesma pessoa que também produz o conteúdo, entrega a mentoria e atende na clínica. [D]

## O paradoxo que precisa ser dito

A WinDoc publica um carrossel chamado "*Antes de comprar mais tráfego, corrija o balde*" e outro chamado "*Sua secretária atende ou converte?*". A empresa vende exatamente a correção deste problema — e opera hoje com o balde furado que ela mesma diagnostica nos clientes. Enquanto o cronograma de 90 dias fixa metas detalhadas de **topo** de funil (seguidores, engajamento, DMs), não existe **uma única meta declarada** para lead → sessão diagnóstica → proposta → matrícula. [D]

(b) Como é hoje

Fluxo real, etapa por etapa

| # | ETAPA           | COMO ACONTECE HOJE                                               | QUEM FAZ                 | É MEDIDO?                         |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Atração         | Posts orgânicos em 2 perfis, cronograma de ~130 posts em 90 dias | Fundador + apoio externo | Parcial (métricas de vaidade) [D] |
| 2 | Captura         | DM, comentário, WhatsApp, formulário → n8n → planilha            | Fundador                 | Não [D]                           |
| 3 | Qualificação    | Conversa manual por DM, sem roteiro fixo nem critério de corte   | Fundador                 | Não [D]                           |
| 4 | Diagnóstico     | Raio-X Estratégico (Google Forms), enviado caso a caso           | Fundador                 | Não [D]                           |
| 5 | Sessão de venda | Call 1:1, consultiva, sem estrutura padronizada                  | Fundador                 | Não [D]                           |
| 6 | Proposta        | Apresentada verbalmente / material avulso                        | Fundador                 | Não [D]                           |
| 7 | Follow-up       | Não existe rotina. Depende de lembrar                            | Fundador                 | Não [D]                           |
| 8 | Reativação      | Não existe                                                       | —                        | Não [D]                           |

Sintomas observáveis

- A planilha de captação de leads da mentoria (integrada via n8n) está composta majoritariamente por **registros de teste** — o canal técnico funciona, o canal comercial está vazio. [D]
- O perfil institucional `@windoc.official` estava em construção em jul/2026; a audiência real mora no perfil pessoal `@dr.fernandojorge` (4.516 seguidores), que atende **dois públicos simultâneos** — paciente e médico — com conteúdo alternado. [D]
- Prova social existe (mentorados com documento estratégico formal e baseline auditável), mas está sub-utilizada: aparece no cronograma como tema de post, não como ativo comercial sistematizado (case estruturado, número auditado, depoimento em vídeo). [D]
- O funil não tem **nome de etapa**. Sem nome, não há medição; sem medição, não há diagnóstico; sem diagnóstico, a decisão sobre "o que fazer para vender mais" volta a ser sensação — que é justamente o erro que a WinDoc combate nos clientes. [D]

Engenharia reversa da meta (modelo, não previsão)

Para dimensionar o problema, invertemos a meta declarada de **2 turmas em 90 dias**:

| PREMISSA                            | VALOR      | ORIGEM                                  |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Alunos por turma                    | 8          | [E] a definir                           |
| Ticket                              | R\$ 60.000 | [D]                                     |
| Conversão proposta → matrícula      | 22%        | [E] benchmark de alto ticket consultivo |
| Conversão sessão → proposta         | 70%        | [E]                                     |
| Conversão lead qualificado → sessão | 30%        | [E]                                     |

Trabalhando de trás para frente para **16 matrículas/ano**:

16 matrículas ÷ 0,22 ≈ 73 propostas  
73 propostas ÷ 0,70 ≈ 104 sessões de diagnóstico  
104 sessões ÷ 0,30 ≈ 347 leads qualificados/ano ≈ 29/mês ≈ 7/semana

**Conclusão que muda a decisão:** a meta de topo de funil do cronograma (30–50 DMs qualificados/semana no dia 90) é **4 a 7 vezes maior** do que os ~7 leads/semana necessários. Ou seja — **o problema da WinDoc não é falta de audiência. É o meio do funil.** Comprar mais tráfego ou publicar mais posts antes de corrigir as etapas 3 a 8 é despejar água no balde furado.

**Aviso metodológico:** os percentuais acima são premissas explícitas, não dados. O valor do modelo não é o número final — é mostrar que **a resposta muda completamente** dependendo de qual etapa está furada, e que hoje é impossível saber qual é sem medição.

### Custo do problema (dimensionamento, com premissas declaradas)

- **Custo de oportunidade direto:** cada 1 ponto percentual de conversão perdido na etapa proposta → matrícula, sobre ~73 propostas/ano, vale ≈ **R\$ 44 mil/ano** ( $0,73 \times \text{R\$ } 60\text{k}$ ).
- **Custo de tempo do fundador:** 104 sessões de diagnóstico/ano ≈ 2/semana. Somadas a 34 encontros de mentoria, produção de conteúdo e atendimento clínico, a agenda do fundador vira o teto de crescimento da empresa.
- **Custo invisível:** leads que entraram, não fecharam e nunca mais foram tocados. Sem CRM, esse número é literalmente desconhecido — e um lead médico de alto ticket costuma precisar de meses de maturação.

### (c) Quem sofre

| ATOR                                 | COMO SOFRE                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dr. Fernando (fundador)</b>       | Vira o gargalo do próprio negócio. Faz conteúdo, vende, entrega e atende na clínica. Cresce só aumentando as próprias horas — exatamente o que ensina a evitar. Risco real de burnout e de estagnação da receita. |
| <b>A WinDoc (empresa)</b>            | Receita imprevisível, sem forecast, sem base para contratar, investir em tráfego ou planejar turmas. Não é ainda uma empresa: é uma operação pessoal de alta qualidade.                                           |
| <b>O médico-lead que não fechou</b>  | Levantou a mão, foi tocado uma vez e nunca mais. Continua preso ao convênio, à agenda cheia com margem baixa e à sensação de que "não dá". Sofre um problema que a WinDoc sabe resolver.                          |
| <b>Os mentorados atuais</b>          | Disputam a atenção de um mentor sobrecarregado com tarefas comerciais que poderiam ser sistematizadas.                                                                                                            |
| <b>A equipe do Instituto Vitalle</b> | Recebe um dono com atenção fracionada entre clínica e escola.                                                                                                                                                     |
| <b>A credibilidade da marca</b>      | Vender "empresarização" sem operar empresarizado é um risco de posicionamento — o dia em que um lead perceber, a autoridade sofre.                                                                                |

(d) O que muda se resolver

Efeitos diretos

- 1. **Previsibilidade.** Com as 8 etapas nomeadas e medidas, "quantos alunos teremos no próximo trimestre" deixa de ser torcida e vira cálculo com margem de erro.
- 2. **Receita destravada sem mais audiência.** Corrigir o meio do funil melhora a receita usando exatamente os mesmos leads de hoje.
- 3. **Tempo do fundador de volta.** Qualificação e preparo de sessão automatizados devolvem horas por semana para entrega e produto — as duas atividades que só ele pode fazer.
- 4. **Degrau de entrada.** Uma oferta intermediária cria caixa recorrente, gera prova social em volume e transforma a mentoria de R\$ 60k em consequência natural, não em salto de fé.
- 5. **Base para escalar de verdade.** Só com funil medido faz sentido contratar um comercial, investir em tráfego pago ou abrir uma terceira turma.

Efeito estratégico (o mais importante)

A WinDoc passa a ser **o próprio case**. O funil corrigido, medido e parcialmente automatizado vira material didático, prova de método e diferencial competitivo: *"o sistema que eu vou te ensinar é o mesmo que me trouxe você até aqui."*

Indicadores de sucesso (definição de "resolvido")

| INDICADOR                                           | HOJE         | META 90 DIAS        |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Etapas do funil nomeadas e medidas                  | 0 de 8       | 8 de 8              |
| Tempo médio de 1ª resposta ao lead                  | Desconhecido | < 4 h úteis         |
| Taxa lead qualificado → sessão                      | Desconhecida | ≥ 30% medida        |
| Taxa proposta → matrícula                           | Desconhecida | ≥ 20% medida        |
| Leads sem toque há >30 dias                         | Desconhecido | 0                   |
| Horas/semana do fundador em tarefa comercial manual | ~alto [E]    | −50%                |
| Receita de oferta de entrada                        | R\$ 0        | > R\$ 0, recorrente |

## (e) Que dados são necessários

### Já existem e temos acesso

| DADO                                              | ONDE ESTÁ                                  | ESTADO                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Respostas do Raio-X Estratégico                   | Google Forms → Google Sheets               | Ativo, subutilizado [D]      |
| Leads do formulário da mentoria                   | n8n → Google Sheets                        | Ativo, base quase vazia [D]  |
| Métricas de Instagram (alcance, salvamentos, DMs) | Instagram Insights / Metricool (conectado) | Ativo, histórico curto [D]   |
| Cronograma editorial e temas publicados           | Documento de 90 dias                       | Ativo [D]                    |
| Casos de mentorados                               | Documentos estratégicos individuais        | Ativo, não sistematizado [D] |
| Agenda e capacidade do fundador                   | Google Calendar                            | Ativo [D]                    |

### Faltam e precisam ser criados (bloqueiam a análise)

| DADO QUE FALTA                                 | POR QUE É INDISPENSÁVEL                            | COMO CAPTURAR                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Registro de lead com etapa e data</b>       | Sem isso nenhuma taxa de conversão existe          | CRM simples (planilha estruturada ou Trello/Notion) desde a semana 1 |
| Origem do lead (post, story, indicação, busca) | Define onde investir esforço                       | Campo obrigatório na captura                                         |
| Data e resultado de cada sessão de diagnóstico | Mede a etapa mais cara do funil                    | Registro pós-call, 2 min                                             |
| Objeção declarada na perda                     | Alimenta conteúdo, script e ajuste de oferta       | Campo obrigatório no "perdido"                                       |
| Nº de propostas emitidas e valor               | Base do forecast                                   | Registro na emissão                                                  |
| Tempo até a 1ª resposta                        | Maior alavanca isolada de conversão em alto ticket | Timestamp automático                                                 |
| Capacidade real de atendimento do fundador     | Define o teto de turmas por ano                    | Bloqueio de agenda                                                   |

### Restrições de dados

- **LGPD:** lead médico é titular de dados pessoais. Base legal, consentimento no formulário e finalidade declarada. Sem lista comprada, sem disparo indiscriminado. [D]
- **Sigilo:** dados de pacientes do Instituto Vitalle **não entram** nesta análise.
- **Honestidade:** nenhum número estimado pode ser apresentado como resultado real, nem em conteúdo, nem em proposta comercial. [D]

## Resumo em uma frase

---

A WinDoc não tem problema de audiência nem de método: tem um funil sem nome, sem medição, sem degrau de entrada e com uma única pessoa em todas as etapas — e por isso vende por esforço, não por sistema.

# O negócio: como a WinDoc atua hoje

negocio.md

Base de conhecimento nº 1 de 3. Descreve **como a empresa atua hoje**. Convenção de confiabilidade usada em todos os arquivos: **[D]** dado documentado (existe em material interno/público da empresa) · **[E]** estimativa do fundador, ainda **não** validada por sistema.

## 1. Identidade

| CAMPO            | CONTEÚDO                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome             | <b>WinDoc</b> — Escola de Empreendedorismo e Empresarização Médica [D]                                                                                              |
| Marca-irmã       | <b>WinDoc Club</b> (comunidade/programa) e <b>DocRegen</b> (braço acadêmico) [D]                                                                                    |
| Fundador         | Dr. Fernando Jorge — CRM-MG 56.816 · CRM-SP 141.444 · RQE 28918 [D]                                                                                                 |
| Clínica-modelo   | Instituto Vitalle — Guaxupé/MG (ortopedia, medicina da dor, medicina regenerativa, terapias injetáveis, fisioterapia) [D]                                           |
| Canais           | windoc.com.br · @windoc.oficial (institucional, público 100% médico) · @dr.fernandojorge (pessoal, 4.516 seguidores em jul/2026) · WhatsApp comercial · Threads [D] |
| Sede operacional | Remota (Brasil), com componente presencial em Guaxupé/MG [D]                                                                                                        |

### Tese central da marca

"Você não precisa abandonar o consultório. Precisa empresarizá-lo." [D]

A promessa não é ensinar medicina. É fazer a travessia **médico técnico → médico líder**: tirar o faturamento da dependência exclusiva das horas do médico e colocá-lo sobre sistema, pessoas, oferta e operação.

## 2. O que vendemos

### 2.1 Produto principal — Mentoria WinDoc (alto ticket)

| ITEM         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formato      | Híbrido, <b>12 meses</b> [D]                                                                                                                                                                     |
| Composição   | 4 encontros semanais iniciais + 20 encontros quinzenais online (~2h) + 4 sessões individuais de Q&A + 1 imersão presencial + 3 dias presenciais dentro da clínica-modelo (Instituto Vitalle) [D] |
| Investimento | <b>R\$ 60.000,00</b> [D]                                                                                                                                                                         |
| Entrega      | Aulas expositivas, estudos de caso, acompanhamento individual, documento estratégico personalizado por mentorado, Sprint de 21 dias, plano 30/60/90 [D]                                          |
| Público      | Médicos de qualquer especialidade, donos (ou futuros donos) de consultório/clínica [D]                                                                                                           |

### 2.2 Ativos metodológicos proprietários (o que nos diferencia)

| ATIVO                                    | FUNÇÃO                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 Pilares WinDoc</b>                  | Mentalidade e Liderança · Modelo de Negócio e Estratégia · Gestão e Pessoas · Comercial e Crescimento [D]                                                                                                     |
| <b>Raio-X Estratégico WinDoc</b>         | Formulário diagnóstico de ~50 perguntas (faturamento, lucro, retirada, agenda, capacidade ociosa, leads, fontes de paciente, script, follow-up, conversão, objeções, ticket, programas de acompanhamento) [D] |
| <b>Sprint de 21 Dias</b>                 | Protocolo de execução dia a dia com checklist, evidência diária e painel enviado ao mentor [D]                                                                                                                |
| <b>Camadas Estratégia / Plano / Ação</b> | Framework de diagnóstico: <i>falta foco</i> → <i>estratégia</i> ; <i>falta coordenação</i> → <i>plano</i> ; <i>falta entrega</i> → <i>execução</i> [D]                                                        |
| <b>Método T.E.M.P.O. Nobre</b>           | Arquitetura estratégica da agenda médica (Triagem, Estruturação, Margem, Priorização, Otimização) [D]                                                                                                         |
| <b>Painel de KPIs da Clínica</b>         | Tratado de implementação: métrica de vaidade × KPI de decisão; "estetoscópio empresarial" [D]                                                                                                                 |
| <b>Clínica-modelo</b>                    | Instituto Vitalle funciona como laboratório real onde o método é testado antes de ser ensinado [D]                                                                                                            |

### 2.3 DocRegen — braço acadêmico

Programa técnico-científico de **ortobiologia / medicina regenerativa** (curso em 3 aulas + apostila "Preparo do Terreno Biológico"), com formulário diagnóstico próprio. [D] Hoje posiciona autoridade científica; **ainda não opera como degrau comercial de entrada** para a mentoria (ver problema.md, insight 1).

### 2.4 Esteira de produtos — como está hoje

Conteúdo gratuito (Instagram/Threads) → R\$ 0  
↓ (salto de R\$ 60.000 – sem degrau intermediário)  
Mentoria WinDoc 12 meses → R\$ 60.000

DocRegen e WinDoc Club existem, mas **não estão precificados nem posicionados como oferta de entrada** com função comercial definida. [D/E]

### 3. Para quem vendemos

Resumo (o detalhamento está em `cliente.md`): médico brasileiro, dono de consultório ou clínica, entre ~32 e ~55 anos, majoritariamente fora das capitais (Sul de Minas como praça-âncora, alcance nacional pelo digital), preso ao convênio e/ou ao plantão, com agenda ocupada e margem baixa, sem processo comercial estruturado e sem indicadores.

### 4. De que forma entregamos (físico / digital / SaaS)

| CAMADA          | NATUREZA              | COMO FUNCIONA HOJE                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquisição       | Digital               | Conteúdo orgânico em 2 perfis de Instagram, cronograma de 90 dias com ~130 posts planejados (Reels 40-45%, carrossel 35%, foto+legenda 20-25%), stories diários, Threads [D] |
| Captura de lead | Digital               | DM do Instagram, WhatsApp comercial, formulário de cadastro integrado a <b>n8n</b> que grava em planilha [D]                                                                 |
| Qualificação    | Manual, pelo fundador | Conversa por DM/WhatsApp conduzida pessoalmente pelo Dr. Fernando [D]                                                                                                        |
| Diagnóstico     | Digital               | Raio-X Estratégico (Google Forms → planilha) [D]                                                                                                                             |
| Venda           | Manual, pelo fundador | Sessão de diagnóstico e apresentação de proposta 1:1 [D]                                                                                                                     |
| Entrega         | Híbrida               | Online quinzenal (Zoom/Meet, com gravação) + imersão presencial + 3 dias na clínica-modelo [D]                                                                               |
| Material        | Digital               | Apostilas, carrosséis, manuais de sprint, documentos estratégicos individuais, apresentações — produzidos com forte apoio de IA [D]                                          |

**Não é SaaS.** É serviço de alto toque com apoio digital. Existe um projeto de plataforma LMS multi-tenant em desenvolvimento neste mesmo repositório ( `apps/` , `services/` , `supabase/` ), que futuramente hospedará a área de membros — hoje ainda não está em produção. [D]

### 5. Modelo econômico e operação

#### 5.1 Estrutura de receita

| FONTE                       | SITUAÇÃO HOJE                                 | MARGEM | ESCALABILIDADE                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| Mentoria WinDoc (R\$ 60k)   | Principal aposta de receita [D]               | Alta   | Baixa — limitada pelas horas do fundador |
| DocRegen (curso)            | Produzido, sem operação comercial ativa [D/E] | Alta   | Média-alta                               |
| Instituto Vitalle (clínica) | Receita separada, sustenta o caixa [D]        | Média  | Baixa (horas médicas)                    |

## 5.2 Time

| FUNÇÃO                                          | QUEM                                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Estratégia, conteúdo, vendas, mentoria, produto | <b>Dr. Fernando Jorge (100%)</b> [D]                         |
| Apoio de social media / produção                | Parceiro externo (cronograma de 90 dias foi coproduzido) [D] |
| Comercial dedicado                              | <b>Não existe</b> [D]                                        |
| CRM / operação de funil                         | <b>Não existe</b> — hoje é planilha + n8n + memória [D]      |

## 5.3 Ativos já construídos (capital que não está sendo capitalizado)

1. Autoridade clínica real: RQE, dupla inscrição CRM, mídia espontânea (Correio Braziliense), imersão internacional (NASA/Silicon Valley). [D]
2. Clínica própria funcionando como prova viva do método. [D]
3. Biblioteca metodológica densa e original (7 ativos listados em 2.2). [D]
4. Biblioteca de conteúdo pronta: ~130 posts planejados e dezenas de carrosséis já diagramados. [D]
5. Casos de mentorados com documento estratégico formal (ex.: um mentorado com baseline de ~R\$ 15k/mês e meta de 90 dias de ~R\$ 30k/mês — identidade preservada). [D]
6. Infraestrutura técnica embrionária: n8n integrado a formulário e planilha. [D]

## 5.4 Metas declaradas para o ciclo de 90 dias (jul → nov/2026) [D]

| MÉTRICA                        | 30 DIAS  | 60 DIAS         | 90 DIAS                     |
|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|
| Seguidores @windoc.official    | +300-500 | +700-1.000      | +1.500-2.000                |
| Seguidores @dr.fernandojorge   | +200-400 | +500-800        | +1.000-1.500 (~6.000 total) |
| Engajamento WinDoc             | ≥3%      | ≥4%             | ≥4,5%                       |
| <b>DMs qualificados/semana</b> | 5-10     | 15-25           | <b>30-50</b>                |
| Turmas WinDoc                  | —        | Turma 1 fechada | Turma 2 fechada             |

Essas metas descrevem **topo de funil**. Não existe meta declarada para lead→sessão diagnóstica, sessão→proposta e proposta→matrícula — que é exatamente onde `problema.md` localiza o gargalo.

## 6. Princípios inegociáveis (restrições que qualquer solução deve respeitar)

1. **Ética médica e publicitária (CFM):** sem promessa de resultado clínico, sem sensacionalismo, sem exposição de paciente identificável.
2. **Honestidade comercial:** metas de faturamento são metas de trabalho, nunca promessa de resultado financeiro garantido — regra já escrita nos documentos entregues a mentorados. [D]
3. **LGPD:** dados de leads médicos e de pacientes tratados com base legal, consentimento registrado e sem lista comprada ou disparo indiscriminado. [D]
4. **Coerência de marca:** a WinDoc ensina sistema comercial. Não pode operar sem sistema comercial próprio.

## 7. Fontes deste documento

---

Materiais internos WinDoc/DocRegen (Google Drive do fundador): cronograma de conteúdo de 90 dias (jul/2026), ebook da Mentoria WinDoc/DocCEO, carrosséis institucionais (7 Sinais, 4 Pilares, Custo Invisível, Consultório x Empresa, Secretária Converte), Método T.E.M.P.O. Nobre, Tratado de KPIs da Clínica WinDoc, formulário e respostas do Raio-X Estratégico, documentos estratégicos do Sprint 21 Dias, planilha de automação de leads (n8n), memorial técnico do Instituto Vitale.

# O cliente: ICP e personas

cliente.md

Base de conhecimento nº 3 de 3. Perfil, faixa etária, gênero, capacidade de desembolso, comportamento, gatilhos, objeções e critérios de exclusão. Convenção: **[D]** documentado · **[E]** estimativa a validar. Fonte primária de campo: perguntas e respostas do **Raio-X Estratégico WinDoc** e dos documentos estratégicos de mentorados. [D]

## 1. ICP em uma frase

**Médico brasileiro, dono do próprio consultório ou clínica, com agenda ocupada e margem baixa, que já entendeu que o problema não é competência clínica — é ausência de empresa — e que tem caixa e maturidade para pagar por um sistema, não por mais um curso.**

## 2. Perfil demográfico e profissional

| DIMENSÃO            | ICP PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profissão           | Médico(a) com CRM ativo, qualquer especialidade. Maior aderência: ortopedia, medicina da dor, medicina regenerativa, ginecologia, endocrinologia/emagrecimento, dermatologia, clínica médica com foco em longevidade [D/E]                                           |
| Faixa etária        | <b>35-52 anos</b> (núcleo 38-48). Abaixo de 32 normalmente falta caixa; acima de 55 normalmente falta apetite por reestruturação [E]                                                                                                                                 |
| Tempo de formado    | 8-25 anos [E]                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gênero              | Ambos. Base atual majoritariamente <b>masculina</b> [E], mas o mercado brasileiro sub-40 é majoritariamente feminino — <b>oportunidade explícita de expansão</b> com personas e linguagem específicas (ex.: sócia-fundadora que concilia clínica, filhos e expansão) |
| Geografia           | Cidades de médio porte e interior — praça-âncora <b>Sul de Minas / Guaxupé</b> , alcance nacional pelo digital. O posicionamento "médico do interior" é diferencial competitivo, não limitação [D]                                                                   |
| Estrutura           | Consultório próprio ou clínica pequena: 1-3 salas, equipe de 1 a 6 pessoas (secretária, recepção, técnico, fisio) [D/E]                                                                                                                                              |
| Situação de mercado | Ainda depende de convênio e/ou plantão; agenda particular existente porém ociosa [D]                                                                                                                                                                                 |

### 3. Capacidade de desembolso

| FAIXA                               | FATURAMENTO BRUTO MENSAL | PERFIL                                                                                             | OFERTA ADEQUADA                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A — Emergente</b>                | R\$ 10k – R\$ 30k        | Renda ainda dependente de plantão; agenda particular ociosa. Motivação altíssima, caixa curto      | <b>Não</b> é ICP da mentoria de R\$ 60k. É ICP da <b>oferta de entrada</b> (R\$ 1,5k – R\$ 5k) [E] |
| <b>B — Núcleo (ICP da mentoria)</b> | R\$ 40k – R\$ 90k        | Consultório funcionando, equipe pequena, dono é o gargalo. Já tem caixa e já sente a dor de escala | <b>Mentoria WinDoc R\$ 60k</b> , tipicamente parcelada em 12–18x [E]                               |
| <b>C — Expansão</b>                 | R\$ 90k+                 | Clínica estruturada, pensa em 2ª unidade, sócios, novas linhas de receita                          | Mentoria + consultoria/imersão premium [E]                                                         |

**Regras práticas de desembolso** (a validar com dados reais):

- Compra é **investimento de carreira**, não despesa: o médico compara com pós, congresso internacional ou equipamento — âncoras de R\$ 20k a R\$ 150k. R\$ 60k é caro, mas está dentro da moldura mental correta. [E]
- Sensibilidade maior a **parcelamento e prazo** do que ao valor absoluto. [E]
- Decisão de R\$ 60k raramente é solitária: **cônjuge e/ou sócio influenciam**. Material que o lead possa mostrar em casa reduz o ciclo de venda. [E]
- Contador/contabilidade influencia (dedução, PJ, forma de pagamento). [E]

### 4. As três personas

#### 4.1 "Dr. Preso ao Convênio" — persona de entrada (não da mentoria)

Baseado em caso real de mentorado. [D]

- 30–40 anos, 5–12 de formado, cidade pequena.
- Faturamento ~R\$ 15k/mês, boa parte vinda de plantão; agenda particular ociosa. [D]
- Gargalo: **não tem sistema previsível de geração de demanda, conversão e acompanhamento**. [D]
- Meta realista de 90 dias: aproximar-se de R\$ 30k/mês. [D]
- **Não consegue pagar R\$ 60k hoje**. Se for tratado como não-cliente, a WinDoc perde a base de onde nascem os clientes B em 12–24 meses.
- Oferta correta: Sprint de 21 dias produzizado / DocRegen / comunidade paga.

## 4.2 "Dr. Consultório Cheio, Margem Vazia" — ICP PRINCIPAL

- 38-50 anos, 12-22 de formado, cidade média.
- R\$ 40k-90k/mês, 3-6 pessoas na equipe, clínica própria ou alugada.
- Agenda lotada. Trabalha muito. Não sabe o lucro líquido. [D — pergunta do Raio-X]
- Secretária **atende, mas não converte**: sem script, sem follow-up, sem CRM. [D]
- Todas as decisões passam por ele; sem ele, o faturamento para. [D]
- Frase-gatilho que o faz parar o scroll: *"30 dias sem você. Sua clínica sobreviveria?"* [D]
- Compra quando entende que **não vai trabalhar mais, vai trabalhar diferente**.

## 4.3 "Dra. Clínica em Expansão" — persona de topo

- 42-55 anos, clínica consolidada, R\$ 90k+/mês, pensa em 2ª unidade, sócios ou sucessão.
- Dor: crescer sem perder padrão, sem virar refém de operação, sem brigar com sócios.
- Compra governança, indicadores, gestão de pessoas e modelo de negócio — os pilares 2 e 3.
- Ciclo de venda mais longo, ticket maior, prova social mais exigente.

---

## 5. Comportamento e jornada

---

### Onde está

Instagram (feed e stories, consumo em dois picos: **6h-8h**, antes do plantão/consulta, e **19h-21h**, em casa), Threads, WhatsApp, grupos de especialidade, congressos, indicação entre colegas. [D]

### Como consome

- Salva carrossel que ensina algo que vai querer reler — salvamento é o sinal de intenção mais forte, mais que curtida. [D]
- Reage a **provocação com número** ("quanto você realmente ganha por hora no convênio?"), não a motivação genérica. [D]
- Confiar em **par**: médico que fala com médico. Rejeita "guru de marketing". [D]
- Consome escondido antes de se declarar: acompanha semanas antes de mandar o primeiro DM.

### Jornada de compra (estado desejado)

|                   |                                         |                         |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1. Reconhecimento | — "esse post está falando de mim"       | → salva / segue         |
| 2. Declaração     | — DM, comentário ou WhatsApp            | → vira lead             |
| 3. Qualificação   | — responde o Raio-X Estratégico         | → vira lead qualificado |
| 4. Diagnóstico    | — sessão 1:1 com devolutiva de valor    | → vira oportunidade     |
| 5. Decisão        | — proposta + conversa com cônjuge/sócio | → vira proposta         |
| 6. Matrícula      | — contrato e parcelamento               | → vira aluno            |
| 7. Prova          | — resultado documentado                 | → vira ativo comercial  |

Hoje as etapas 3 a 7 existem na prática mas **não existem no sistema** — ver problema.md.

---

## 6. Gatilhos de compra

| GATILHO                              | FORMULAÇÃO QUE FUNCIONA                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perda de tempo de vida</b>        | "Você está em casa, jantando com a família, mas uma parte da cabeça continua na clínica." [D] |
| <b>Teto de crescimento</b>           | "Mais crescimento = mais agenda" × "mais crescimento = melhor modelo." [D]                    |
| <b>Vergonha silenciosa do número</b> | Não sabe quantos leads entraram no último mês. [D]                                            |
| <b>Perda concreta e mensurável</b>   | O balde furado: paciente entra, não agenda, ninguém acompanha. [D]                            |
| <b>Prova de par</b>                  | Colega de perfil parecido que mudou de patamar com número auditável.                          |
| <b>Legitimação ética</b>             | "Empreender na medicina não é trair a vocação — é honrá-la." [D]                              |
| <b>Evento de vida</b>                | Abertura de clínica própria, saída de sociedade, nascimento de filho, burnout.                |

## 7. Objeções (e o que cada uma realmente significa)

| OBJEÇÃO DECLARADA                         | SIGNIFICADO REAL                         | RESPOSTA ESTRUTURAL                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| "Não tenho tempo"                         | Não acredita que vá economizar tempo     | Mostrar o método pelo tempo devolvido (T.E.M.P.O. Nobre), não pelo tempo exigido     |
| "Está caro"                               | Não enxergou o retorno em número próprio | Devolutiva do Raio-X com o custo atual do problema <b>dele</b> , calculado           |
| "Vou pensar / falar em casa"              | Falta material para o decisor ausente    | Dossiê de 1 página que o lead leva para cônjuge/sócio                                |
| "Aqui no interior não dá pra cobrar caro" | Crença de praça                          | Quebra com dado (renda do interior, agronegócio, menos concorrência qualificada) [D] |
| "Já fiz curso e não mudou nada"           | Medo de comprar teoria de novo           | Diferencial: sprint com evidência diária, clínica-modelo, acompanhamento individual  |
| "Meus colegas vão me julgar"              | Medo de reputação                        | Enquadramento ético e regulatório do marketing médico [D]                            |
| "Vou tentar sozinho primeiro"             | Subestima o custo do atraso              | Custo de 12 meses de tentativa × custo do programa                                   |

As **5 objeções mais frequentes** já são pergunta obrigatória do Raio-X Estratégico — portanto essa tabela pode e deve ser substituída por dado real assim que houver volume. [D]

## 8. Anti-ICP (a quem dizer não)

---

- Médico que quer **fórmula de faturamento rápido** sem mudar operação.
  - Quem não tem (nem quer ter) consultório/clínica própria — CLT puro ou plantonista sem projeto de negócio.
  - Quem busca marketing agressivo ou promessa clínica — conflita com o pilar ético. [D]
  - Quem não tem caixa mínimo para atravessar 12 meses de programa: vender para esse perfil gera inadimplência, frustração e case negativo.
  - Quem quer terceirizar a execução: a WinDoc entrega sistema e cobrança, não faz por ele.
- 

## 9. O que precisamos saber e ainda não sabemos sobre o cliente

---

1. Distribuição real da base entre personas A / B / C.
2. Especialidades que mais convertem (não as que mais engajam — não é a mesma coisa).
3. Faixa etária real dos leads que **fecham**, não dos que seguem.
4. Peso real do cônjuge/sócio na decisão.
5. Tempo médio entre 1º contato e matrícula (ciclo de venda).
6. Proporção geográfica: interior x capital.
7. Qual conteúdo precedeu a matrícula — atribuição do último e do primeiro toque.

Todos os sete são capturáveis com **três campos obrigatórios** no CRM (origem, persona, especialidade) e **um campo** no fechamento (motivo declarado). Custo: minutos por lead. Valor: a diferença entre marketing por sensação e marketing por dado.

# Entrega 1 — o prompt

prompt.md

---

**Entrega 1 de 2 da tarefa.** Este é o prompt que foi dado ao Claude dentro do Claude Code, tendo `problema.md`, `negocio.md` e `cliente.md` como base de conhecimento no mesmo diretório. A resposta gerada está em `resposta.md`.

---

## Parte I — O prompt (versão para copiar)

### # PAPEL

Você é um conselheiro de crescimento (growth advisor) sênior, especializado em negócios de educação executiva de alto ticket e em serviços profissionais do setor de saúde no Brasil. Você já estruturou funis comerciais para mentorias de ticket acima de R\$ 30.000 e conhece as restrições éticas da publicidade médica (CFM) e a LGPD. Você é direto, quantitativo e não motivacional. Você recomenda; não oferece cardápios de opções.

### # BASE DE CONHECIMENTO

Leia integralmente, nesta ordem, os três arquivos deste diretório antes de responder qualquer coisa:

1. `negocio.md` – como a empresa atua hoje
2. `problema.md` – o problema a resolver (captação e conversão)
3. `cliente.md` – o ICP

Regras sobre a base:

- Os arquivos marcam cada informação como [D] (documentado) ou [E] (estimativa não validada). Trate [D] como fato e [E] como hipótese que precisa de teste.
- Não invente números. Se um número for necessário e não existir, declare-o como premissa, marque a fonte como "premissa minha", e mostre como validá-lo.
- Se uma conclusão sua depender inteiramente de um dado [E], diga isso na frente da conclusão. Não esconda a fragilidade dentro do texto.

### # MISSÃO

Produzir um documento de decisão que responda a uma única pergunta:

"Nos próximos 90 dias, o que a WinDoc deve fazer para transformar audiência em matrículas, sem depender de aumentar o volume de conteúdo nem o esforço pessoal do fundador?"

O documento precisa entregar três coisas, nesta ordem:

- (1) DIAGNÓSTICO – onde exatamente o valor está vazando, com evidência
- (2) PLANO – o que fazer em 30 / 60 / 90 dias, com dono, indicador e data
- (3) AUTOMAÇÃO – uma automação concreta que destrave o processo repetitivo mais caro, usando prioritariamente ferramentas que a empresa JÁ possui

### # MÉTODO DE RACIOCÍNIO OBRIGATÓRIO

Antes de escrever a resposta final, execute mentalmente estas seis etapas e depois exponha o resultado de cada uma:

1. MAPEIE o funil em etapas nomeadas, do primeiro contato até a matrícula.
2. CLASSIFIQUE cada etapa em: existe e é medida / existe e não é medida / não existe.
3. LOCALIZE o gargalo. Use o teste de falseamento: para cada etapa candidata a gargalo, pergunte "se eu dobrasse o volume da etapa anterior, o resultado final dobraria?". Se a resposta for não, o gargalo está adiante – não atrás.
4. SEPARE por camada, usando o framework da própria empresa:  
falta foco -> ESTRATÉGIA · falta coordenação -> PLANO · falta entrega -> AÇÃO.  
Um problema de estratégia nunca deve ser tratado com mais tarefa.
5. PRIORIZE com ICE (Impacto 1-10 × Confiança 1-10 × Facilidade 1-10). Mostre a nota de cada iniciativa. Corte o que não estiver no topo.
6. CRITIQUE seu próprio plano: qual é a maior chance de ele falhar na prática, considerando que o fundador tem tempo escasso e também atende em clínica?

### # REGRAS INEGOCIÁVEIS

- Ética médica: nada que viole a publicidade médica do CFM. Sem promessa de resultado clínico, sem sensacionalismo, sem exposição de paciente.
- Honestidade comercial: metas de faturamento são metas de trabalho, jamais promessa de resultado garantido. Aplique isso inclusive à WinDoc.

- LGPD: nenhuma recomendação que envolva lista comprada, disparo indiscriminado ou uso de dado sem base legal e consentimento.
- Coerência de marca: a WinDoc ensina sistema comercial. Nenhuma recomendação pode ser algo que ela condenaria em um cliente.
- Realismo de recursos: o time é uma pessoa (mais apoio pontual de social media). Qualquer plano que exija contratar antes de medir está errado.
- Alavanca antes de esforço: priorize o que aumenta resultado SEM aumentar volume de trabalho. "Postar mais" é resposta proibida.

#### # FORMATO DA SAÍDA

Markdown, português do Brasil, com estas seções exatas e nesta ordem:

1. Sumário executivo – no máximo 5 linhas, começando pela conclusão
2. Premissas e limites desta análise – tabela: premissa | valor | por que importa | como validar
3. Diagnóstico do funil – tabela das etapas com status, e o gargalo nomeado com justificativa
4. Os três insights que mudam a decisão – cada um com: o que é, a evidência, o que fazer
5. Priorização ICE – tabela com nota e corte explícito do que NÃO será feito agora
6. Plano 30 / 60 / 90 – tabela: ação | dono | entregável | indicador | prazo
7. A automação – problema que resolve, fluxo passo a passo, ferramentas, o que entra, o que sai, tempo economizado por semana, custo estimado, riscos
8. Painel de indicadores – no máximo 7 KPIs, com meta e frequência de leitura
9. Riscos, ética e o que pode dar errado
10. O que eu não consegui responder – e qual dado destravaria cada resposta

Restrições de forma:

- Tabelas sempre que houver comparação. Prosa curta entre elas.
- Nada de linguagem motivacional, nada de "é importante ressaltar", nada de bullet genérico que serviria para qualquer empresa.
- Todo número deve vir acompanhado de sua origem: [D], [E] ou "premissa minha".
- Se você recomendar algo, recomende de fato: escolha uma opção e defenda.

#### # TESTE FINAL ANTES DE ENTREGAR

Reveja seu texto e elimine qualquer frase que continuaria verdadeira se trocássemos "WinDoc" por qualquer outra empresa. O que sobrar é a resposta.

---

## Parte II — Anatomia do prompt: por que cada bloco existe

---

A tarefa pedia técnica de prompting, não só um pedido bem escrito. Cada bloco acima resolve uma falha conhecida de modelos de linguagem:

| BLOCO                                                        | TÉCNICA                                                                                                                                                        | FALHA QUE EVITA                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAPEL</b>                                                 | <i>Role prompting</i> com especificidade de domínio, senioridade e <b>estilo</b> ("direto, quantitativo, não motivacional", "recomenda, não oferece cardápio") | Resposta genérica de consultor. Sem definir o estilo, o modelo devolve lista de opções e empurra a decisão de volta para quem perguntou    |
| <b>BASE DE CONHECIMENTO</b>                                  | <i>Context grounding</i> por arquivos + <b>ordem de leitura</b> obrigatória                                                                                    | Resposta baseada no conhecimento geral do modelo sobre "mentorias" em vez do negócio real                                                  |
| <b>Marcação [D] / [E]</b>                                    | <i>Epistemic tagging</i> — o próprio corpus declara o que é fato e o que é achismo                                                                             | O modelo tratar estimativa do fundador como se fosse dado auditado e construir um plano inteiro sobre areia                                |
| " <b>Não invente números</b> " + declarar premissa           | <i>Anti-hallucination guardrail</i> com válvula de escape                                                                                                      | Alucinação de métrica. Sem a válvula ("declare como premissa"), o modelo simplesmente inventa em silêncio                                  |
| <b>MISSÃO com pergunta única</b>                             | <i>Single-question framing</i>                                                                                                                                 | Resposta enciclopédica. Uma pergunta só força hierarquia                                                                                   |
| "...sem aumentar volume de conteúdo nem esforço do fundador" | <i>Constraint-driven creativity</i>                                                                                                                            | A resposta preguiçosa ("poste mais", "invista em tráfego") fica proibida por construção                                                    |
| <b>MÉTODO DE RACIOCÍNIO, 6 etapas</b>                        | <i>Chain-of-thought estruturado</i> — raciocínio prescrito, não livre                                                                                          | Pular do problema para a solução. Etapas explícitas obrigam o modelo a mostrar o caminho                                                   |
| <b>Etapas 3, teste de falseamento</b>                        | <i>Falsifiability check</i>                                                                                                                                    | Confundir sintoma com causa. A pergunta "se eu dobrasse a etapa anterior, dobraria o fim?" é o que separa gargalo real de gargalo aparente |
| <b>Etapas 4, camadas do próprio cliente</b>                  | <i>Framework injection</i> — usar o vocabulário proprietário da empresa                                                                                        | Recomendação que não conversa com o método que a empresa já ensina                                                                         |
| <b>Etapas 5, ICE</b>                                         | <i>Forced ranking</i> com nota numérica                                                                                                                        | Lista de 15 boas ideias sem prioridade — que na prática vira zero ideia executada                                                          |
| <b>Etapas 6, autocrítica</b>                                 | <i>Self-critique / reflexion</i>                                                                                                                               | Plano bonito e inexecutável. Obrigar o modelo a atacar o próprio plano melhora a qualidade do plano                                        |
| <b>REGRAS INEGOCIÁVEIS</b>                                   | <i>Hard constraints</i> de compliance (CFM, LGPD) e de coerência de marca                                                                                      | Sugestão ilegal, antiética ou incoerente com o que a empresa prega                                                                         |
| " <b>Realismo de recursos</b> "                              | <i>Resource grounding</i>                                                                                                                                      | Plano de time de 10 pessoas para uma operação de 1 pessoa                                                                                  |
| <b>FORMATO DA SAÍDA</b>                                      | <i>Output schema</i> com seções nomeadas e numeradas                                                                                                           | Saída inconsistente e impossível de comparar entre execuções                                                                               |
| <b>Seção 10 obrigatória</b>                                  | <i>Forced epistemic humility</i>                                                                                                                               | O modelo fingir que respondeu tudo. Pedir explicitamente o que ele <b>não</b> conseguiu responder transforma limitação em próxima tarefa   |
| <b>TESTE FINAL</b>                                           | <i>Specificity filter</i> — critério de eliminação, não de geração                                                                                             | Texto que serve para qualquer empresa. É o filtro mais barato e mais eficaz do prompt inteiro                                              |

## Técnica usada para construir a base de conhecimento (MetaPrompt)

Os três arquivos `.md` não foram escritos "no chute". Foram gerados com a técnica de **MetaPrompt / entrevista invertida** sugerida no enunciado: em vez de descrever o negócio de uma vez, a IA foi instruída a **fazer as perguntas** e a puxar contexto real das fontes disponíveis (materiais internos da WinDoc no Google Drive, o cronograma editorial de 90 dias, o ebook da mentoria, o formulário Raio-X Estratégico, os documentos estratégicos de mentorados e a planilha de automação de leads). O fundador decidiu apenas os quatro pontos de bifurcação:

1. qual negócio seria o foco (WinDoc, e não a clínica),
2. qual dor atacar (captação e conversão),
3. que tipo de entregável gerar (diagnóstico + plano + automação),
4. qual a qualidade dos dados disponíveis (números aproximados, não auditados).

Esse último ponto foi o que originou toda a arquitetura **[D] / [E]** do prompt — e é, provavelmente, a decisão de engenharia de prompt mais importante deste trabalho: quando a base é parcialmente estimada, o risco número um não é a IA errar, é a IA **acertar com confiança falsa**.

# Entrega 2 — a resposta gerada

resposta.md

**Entrega 2 de 2 da tarefa.** Documento produzido pelo Claude (Claude Code) a partir do prompt em `prompt.md`, tendo `negocio.md`, `problema.md` e `cliente.md` como base de conhecimento. Origem de cada número: **[D]** documentado · **[E]** estimativa do fundador · **[P]** premissa minha (da IA), declarada e falseável.

## 1. Sumário executivo

A WinDoc não tem problema de audiência: tem problema de **meio de funil e de degrau de oferta**. A meta de topo do cronograma (30–50 DMs qualificados/semana) é 4 a 7× maior do que os ~7 leads/semana necessários para as duas turmas — logo, produzir mais conteúdo não move o resultado. O valor vaza em três pontos: um salto de R\$ 0 para R\$ 60.000 sem degrau intermediário, a inexistência de qualquer registro entre "interesse declarado" e "sessão de diagnóstico", e um instrumento de venda de altíssima potência — o Raio-X Estratégico — sendo usado como formulário de cadastro. **Recomendação: instrumentar em 30 dias, converter em 60, automatizar em 90 — nesta ordem, sem inverter.**

## 2. Premissas e limites desta análise

| PREMISSA                                          | VALOR USADO  | ORIGEM | POR QUE IMPORTA                                | COMO VALIDAR                                        |
|---------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Alunos por turma                                  | 8            | [P]    | Define toda a engenharia reversa do funil      | Decisão do fundador sobre capacidade de atendimento |
| Ticket da mentoria                                | R\$ 60.000   | [D]    | Base do cálculo de receita                     | Já documentado                                      |
| Conversão proposta → matrícula                    | 22%          | [P]    | Alavanca mais cara do funil                    | 90 dias de CRM                                      |
| Conversão sessão → proposta                       | 70%          | [P]    | Mede a qualidade da qualificação               | 90 dias de CRM                                      |
| Conversão lead qual. → sessão                     | 30%          | [P]    | <b>É a etapa que eu suspeito ser o gargalo</b> | 90 dias de CRM                                      |
| Leads reais entrando hoje                         | Desconhecido | —      | Sem isso, tudo acima é modelo                  | CRM desde a semana 1                                |
| Horas/semana do fundador em tarefa comercial      | "alto"       | [E]    | Define o ganho da automação                    | Auditoria de agenda, 2 semanas                      |
| Audiência: 4.516 seg. (@dr.fernandojorge, jul/26) | 4.516        | [D]    | Base de topo de funil                          | Já documentado                                      |

**Limite honesto desta análise:** nenhuma taxa de conversão da WinDoc é conhecida hoje. Tudo na seção 3 que não estiver marcado [D] é hipótese estruturada, não medição. O plano da seção 6 foi desenhado justamente para que, em 90 dias, esta tabela possa ser reescrita com [D] em todas as linhas.

### 3. Diagnóstico do funil

#### 3.1 Estado das etapas

| # | ETAPA                          | EXISTE?    | É MEDIDA?          | DONO             | VEREDICTO                           |
|---|--------------------------------|------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Atração (conteúdo orgânico)    | Sim, forte | Parcial ( vaidade) | Fundador + apoio | Saudável                            |
| 2 | Captura (DM / WhatsApp / form) | Sim        | Não                | Fundador         | Vaza                                |
| 3 | <b>Qualificação</b>            | Informal   | Não                | Fundador         | <b>Gargalo</b>                      |
| 4 | <b>Agendamento da sessão</b>   | Ad hoc     | Não                | Fundador         | <b>Gargalo</b>                      |
| 5 | Sessão de diagnóstico          | Sim        | Não                | Fundador         | Depende 100% do fundador            |
| 6 | Proposta                       | Sim        | Não                | Fundador         | Sem material para o decisor ausente |
| 7 | Follow-up                      | Não existe | —                  | —                | Vazamento total                     |
| 8 | Reativação                     | Não existe | —                  | —                | Vazamento total                     |

0 de 8 etapas medidas. [D]

#### 3.2 Teste de falseamento — onde está o gargalo de verdade

*Pergunta aplicada a cada etapa: se eu dobrasse o volume da etapa anterior, o número de matrículas dobraria?*

| ETAPA CANDIDATA                   | SE DOBRASSE O VOLUME ANTERIOR...                             | CONCLUSÃO                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Atração                           | Mais alcance, mesmos DMs mal aproveitados                    | Não dobra. Gargalo está adiante |
| Captura                           | Mais DMs, mesma capacidade manual de 1 pessoa                | Não dobra. Gargalo está adiante |
| <b>Qualificação → Agendamento</b> | Mais leads qualificados e sessões agendadas → mais propostas | <b>Sim, dobraria. ← GARGALO</b> |
| Sessão de venda                   | Mais sessões só existem se a etapa 3-4 entregar              | Consequência, não causa         |
| Follow-up                         | Recupera o que já vazou; amplia, não origina                 | Multiplicador, não gargalo      |

**Gargalo nomeado: a passagem entre "interesse declarado" e "sessão de diagnóstico agendada" (etapas 3 e 4).** É o único ponto do funil onde aumentar o volume de entrada aumenta proporcionalmente a saída — e é o único que hoje não tem processo, nem critério, nem registro, nem prazo.

### 3.3 Separação por camada (framework da própria WinDoc)

| CAMADA                            | DIAGNÓSTICO                                                                                                   | NÃO CONFUNDIR COM                                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTRATÉGIA</b><br>(falta foco) | Esteira com um único degrau: R\$ 0 → R\$ 60.000. A maioria da audiência não pode comprar nada, mesmo querendo | Isso <b>não</b> se resolve com mais tarefa nem mais post                                   |
| <b>PLANO</b> (falta coordenação)  | Sem CRM, sem etapas nomeadas, sem SLA de resposta, sem cadência de follow-up, sem dono                        | Não é falta de esforço                                                                     |
| <b>AÇÃO</b> (falta entrega)       | A execução é boa. Conteúdo sai, material sai, mentoria acontece                                               | <b>Aqui não está o problema</b> — e é exatamente por isso que "trabalhar mais" não resolve |

**Implicação direta:** o erro mais provável que a WinDoc cometeria agora é tratar um problema de estratégia e de plano com mais ação. Mais posts, mais stories, mais horas. É o mesmo erro que a WinDoc diagnostica nos clientes dela.

## 4. Os três insights que mudam a decisão

### Insight 1 — O penhasco de oferta é o problema estratégico nº 1

**O que é.** Entre o conteúdo gratuito e a mentoria de R\$ 60.000 não há nada. O médico que se identifica com o conteúdo tem duas opções: consumir de graça para sempre, ou assumir o maior compromisso de desenvolvimento profissional da carreira dele com quem ele conhece há três semanas.

**A evidência.** A persona A ("Dr. Preso ao Convênio", ~R\$ 15k/mês, caso real de mentorado) é a **maior fatia da audiência** e a que mais engaja com o conteúdo de dor — e é economicamente incapaz de comprar o único produto à venda. [D] Ao mesmo tempo, existem dois ativos prontos e ociosos: o **Sprint de 21 Dias** (protocolo completo, com checklist diário, painel e entregáveis obrigatórios) e o **DocRegen** (curso técnico com apostila e 3 aulas produzidas). Ambos existem como material; nenhum existe como oferta. [D]

**O que fazer.** Produzizar o **Sprint de 21 Dias** como oferta de entrada, faixa **R\$ 1.900 - R\$ 4.900** [P], em turma, com esforço de entrega majoritariamente já construído. Três funções, nesta ordem de importância:

1. **Filtro.** Quem paga R\$ 2k e executa 21 dias de checklist é candidato real a R\$ 60k. Quem não executa, se auto-eliminou por R\$ 2k em vez de virar um aluno insatisfeito de R\$ 60k.
2. **Prova social em volume.** 20 participantes por trimestre geram 20 histórias com número, não 2.
3. **Caixa que financia o funil.** Receita recorrente que paga a automação, o tráfego e, eventualmente, o primeiro comercial.

**Aviso de confiança:** a faixa de preço é premissa minha [P]. Validar com 10 conversas de precificação com leads reais antes de publicar qualquer valor.

**Insight 2 — O Raio-X Estratégico é o melhor instrumento de vendas da empresa, e está sendo usado como formulário**

**O que é.** O Raio-X Estratégico tem ~50 perguntas que obrigam o médico a confrontar números que ele evita: faturamento dos últimos 3 meses, lucro líquido, retirada, horas ociosas, leads/mês, conversão percebida, etapa em que mais perde paciente, 5 objeções mais frequentes, ticket. [D]

**A evidência.** Isso não é um cadastro. É uma **sessão de consultoria diagnóstica em formato assíncrono** — e o carrossel institucional da própria WinDoc já nomeia o mecanismo: *"Você não sabe quantos leads entraram no último mês. Sem números, aquisição vira percepção."* [D] Hoje o lead preenche e **não recebe nada de volta**. Todo o valor psicológico gerado (desconforto produtivo + reciprocidade) é desperdiçado no exato momento em que ele está mais quente.

**O que fazer.** Transformar o Raio-X em **motor de conversão**: submissão → devolutiva de valor em até 24h com **três números calculados a partir das respostas dele**, não do discurso da WinDoc:

| NÚMERO DEVOLVIDO          | FÓRMULA (CAMPOS QUE JÁ EXISTEM NO RAI-O-X)                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Seu R\$/hora real         | faturamento mensal ÷ (horas semanais de atendimento × 4,3)   |
| Sua receita ociosa mensal | horários ociosos/semana × valor da consulta × 4,3            |
| Seu balde furado          | leads/mês × (1 – taxa de conversão percebida) × ticket médio |

Três números, o gargalo mais provável dele e **um** próximo passo. Nada de venda no documento. A venda acontece porque o médico acabou de ver, em números próprios, o custo de continuar. Este é o **pilar central da automação da seção 7**.

**Insight 3 — A prova social existe, mas não está em formato vendável**

**O que é.** Existem mentorados com documento estratégico formal, baseline financeiro declarado, meta de 90 dias e painel de acompanhamento diário — nível de rastreabilidade que a maioria das mentorias do mercado não tem. [D] Mas esse material vive em PDFs internos. No cronograma editorial, "case de aluno" aparece como **tema de post**, não como ativo estruturado. [D]

**A evidência.** O ICP compra por **prova de par** e rejeita guru. [D] Em alto ticket, a objeção real quase nunca é preço — é *"já fiz curso e não mudou nada"*. [D] O antídoto específico dessa objeção é um par com número auditável, não um depoimento emocionado.

**O que fazer.** Três cases estruturados, com autorização por escrito, no formato: *ponto de partida (número) → o que foi mudado (mecanismo, não motivação) → resultado (número, com o disclaimer honesto de que resultado não é promessa)*. Um por persona (A, B, C). Reutilizáveis em: devolutiva do Raio-X, sessão de diagnóstico, proposta, página de vendas e conteúdo. Um ativo, cinco usos.

5. Priorização ICE

Impacto × Confiança × Facilidade, escala 1–10. Nota máxima 1.000.

| #  | INICIATIVA                                                                                                  | I  | C  | F  | ICE        | DECISÃO                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------|------------------------------|
| 1  | CRM mínimo: 8 etapas nomeadas + campos obrigatórios (origem, persona, especialidade, data, motivo da perda) | 9  | 10 | 9  | <b>810</b> | <b>Fazer já</b>              |
| 2  | Cadência de follow-up D+2 / D+5 / D+12 / D+30                                                               | 8  | 9  | 9  | <b>648</b> | <b>Fazer já</b>              |
| 3  | SLA de 1ª resposta < 4h úteis + 3 scripts de qualificação                                                   | 7  | 9  | 10 | <b>630</b> | <b>Fazer já</b>              |
| 4  | Automação do Raio-X (devolutiva + dossiê + score)                                                           | 10 | 8  | 6  | <b>480</b> | Fazer na fase 3              |
| 5  | Oferta de entrada (Sprint 21 Dias produtizado)                                                              | 10 | 7  | 6  | <b>420</b> | Decidir já, lançar na fase 2 |
| 6  | 3 cases estruturados com número auditado                                                                    | 8  | 8  | 5  | <b>320</b> | Fase 2                       |
| 7  | Migração da audiência médica para @windoc.official                                                          | 6  | 6  | 6  | <b>216</b> | Fase 3, contínuo             |
| 8  | Tráfego pago                                                                                                | 5  | 4  | 5  | <b>100</b> | <b>✗ Cortado</b>             |
| 9  | Plataforma LMS própria em produção                                                                          | 4  | 6  | 2  | <b>48</b>  | <b>✗ Cortado</b>             |
| 10 | Aumentar volume de conteúdo                                                                                 | 3  | 5  | 4  | <b>60</b>  | <b>✗ Cortado</b>             |

## O que NÃO será feito agora — e por quê

- **Tráfego pago (✗).** Comprar tráfego com funil não medido é comprar volume para um balde furado. O CAC seria calculado sobre uma conversão desconhecida. Reavaliar no dia 90, **com dado**. É literalmente o que o carrossel *"Antes de comprar mais tráfego, corrija o balde"* diz. Segui-lo.
- **Plataforma LMS própria (✗).** Alto esforço de engenharia, zero impacto no gargalo diagnosticado. Área de membros não vende: ela entrega. Retomar quando houver volume que justifique.
- **Mais conteúdo (✗).** A restrição estava no prompt e o diagnóstico a confirma: o topo de funil já é 4-7x maior que o necessário.
- **Contratar comercial (✗ por ora).** Contratar antes de medir é transferir um processo indefinido para outra pessoa. Primeiro o processo existe e é medido; depois se delega.

## 6. Plano 30 / 60 / 90

**Princípio de sequenciamento:** não se automatiza um processo que ainda não existe. Automatizar caos produz caos mais rápido. Por isso a automação de maior ICE entre as estruturais (480) vem na fase 3, e não na fase 1.

## Fase 1 — Dias 1-30 · INSTRUMENTAR (*objetivo: parar de decidir por sensação*)

| AÇÃO                                                                                                                                   | DONO     | ENTREGÁVEL                                       | INDICADOR                           | PRAZO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Nomear as 8 etapas do funil e criar o CRM mínimo (Trello, Notion ou planilha estruturada — a ferramenta é irrelevante, o registro não) | Fundador | Quadro com 8 colunas e 5 campos obrigatórios     | 100% dos leads novos registrados    | D+7   |
| Recuperar e registrar retroativamente todos os leads dos últimos 90 dias                                                               | Fundador | Base inicial povoada                             | Nº de leads recuperados             | D+14  |
| Definir SLA de 1ª resposta < 4h úteis                                                                                                  | Fundador | Regra escrita + alerta configurado               | Mediana do tempo de 1ª resposta     | D+7   |
| Escrever 3 scripts: boas-vindas, qualificação, convite para o Raio-X                                                                   | Fundador | Respostas rápidas salvas no Instagram e WhatsApp | Scripts em uso em 100% dos contatos | D+10  |
| Implantar cadência manual de follow-up D+2 / D+5 / D+12 / D+30                                                                         | Fundador | Tarefas recorrentes no CRM                       | Leads sem toque há >30 dias = 0     | D+14  |
| Escrever a devolutiva do Raio-X <b>à mão</b> para os 5 primeiros leads                                                                 | Fundador | 5 devolutivas de 1 página                        | Taxa de resposta à devolutiva       | D+21  |
| Audit a agenda: quanto tempo/semana vai em tarefa comercial manual                                                                     | Fundador | Planilha de 2 semanas                            | Baseline de horas                   | D+21  |
| <b>Decidir</b> formato, escopo e preço da oferta de entrada (10 conversas de precificação)                                             | Fundador | Documento de oferta de 1 página                  | Decisão tomada (sim/não)            | D+30  |

A tarefa "escrever à mão as 5 primeiras devolutivas" não é desperdício: é a especificação da automação da fase 3. Só se automatiza bem o que já se fez à mão.

## Fase 2 — Dias 31-60 · CONVERTER (*objetivo: consertar o balde*)

| AÇÃO                                                                                                            | DONO     | ENTREGÁVEL                     | INDICADOR                  | PRAZO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|-------|
| Lançar a oferta de entrada (turma piloto, vagas limitadas por capacidade real)                                  | Fundador | Turma piloto vendida           | Nº de matrículas + receita | D+45  |
| Produzir 3 cases estruturados (1 por persona) com autorização por escrito                                       | Fundador | 3 one-pagers + 3 vídeos curtos | Uso em 100% das propostas  | D+50  |
| Padronizar a sessão de diagnóstico: roteiro fixo, devolutiva de valor, próximo passo definido antes de encerrar | Fundador | Roteiro de 1 página            | Taxa sessão → proposta     | D+40  |
| Criar o dossiê de 1 página que o lead leva para cônjuge/sócio                                                   | Fundador | Template de proposta           | Ciclo de venda (dias)      | D+50  |
| Primeira leitura formal do painel (seção 8) e ajuste do script pela objeção mais frequente registrada           | Fundador | Ata de revisão                 | Taxa proposta → matrícula  | D+60  |

Fase 3 — Dias 61-90 · AUTOMATIZAR (objetivo: devolver tempo e escalar)

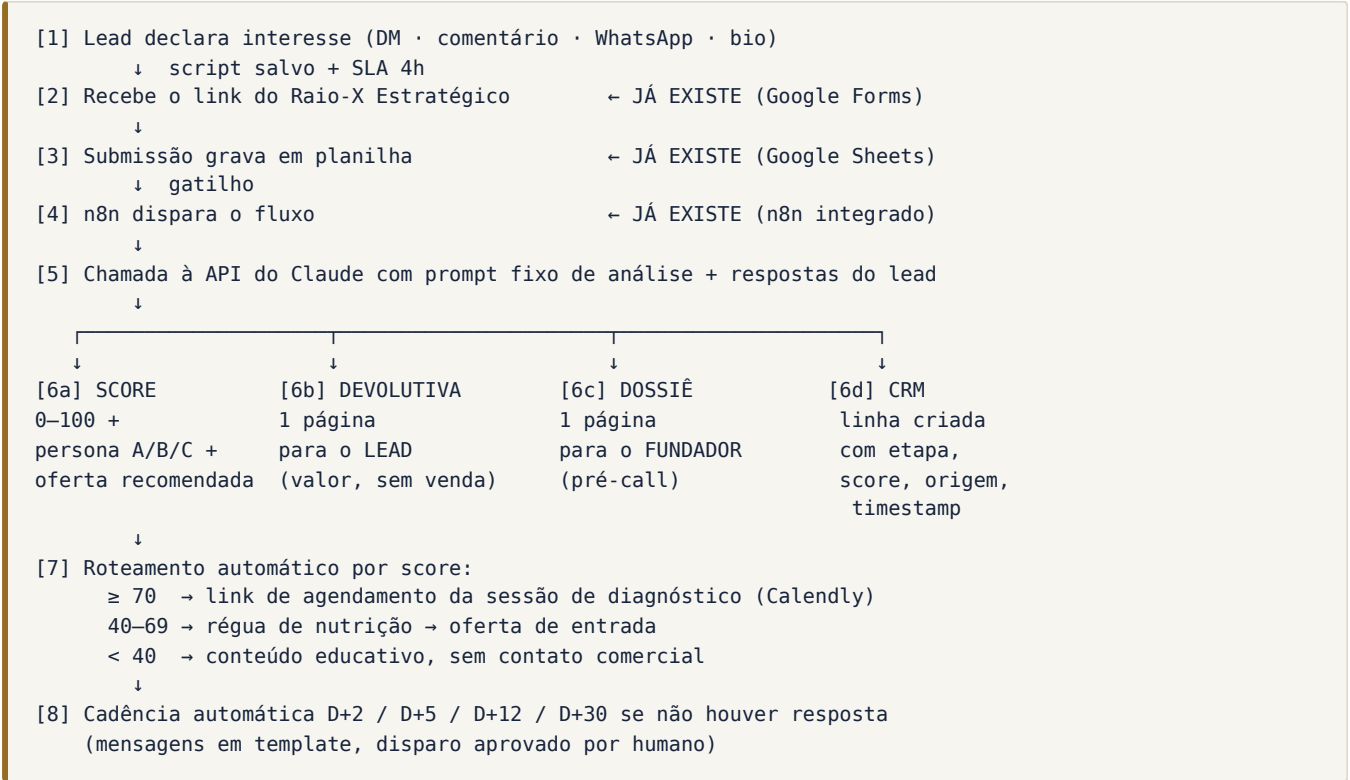
| AÇÃO                                                                                                                                                              | DONO                     | ENTREGÁVEL                  | INDICADOR                                  | PRAZO    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|
| Construir o Motor de Diagnóstico Raio-X (seção 7)                                                                                                                 | Fundador + apoio técnico | Fluxo n8n em produção       | Devolutivas entregues em <24h              | D+75     |
| Ligar a régua automática de nutrição para score baixo (rota para a oferta de entrada)                                                                             | Fundador                 | Sequência de 4 mensagens    | Taxa de reengajamento                      | D+80     |
| Campanha de reativação da base histórica com a devolutiva como isca                                                                                               | Fundador                 | Lista trabalhada            | Nº de sessões geradas da base antiga       | D+85     |
| Migrar progressivamente a audiência médica de @dr.fernandojorge para @windoc.oficial                                                                              | Fundador + social        | Cross-promotion estruturada | Crescimento e engajamento do institucional | Contínuo |
| <b>Revisão de 90 dias:</b> reescrever a tabela de premissas (seção 2) trocando [P] por [D] e decidir sobre tráfego pago e contratação comercial — <b>com dado</b> | Fundador                 | Documento de decisão        | Todas as taxas do funil conhecidas         | D+90     |

7. A automação — "Motor de Diagnóstico Raio-X"

7.1 O problema que resolve

O processo repetitivo mais caro da WinDoc não é produzir conteúdo: é **qualificar um lead e se preparar para a sessão de diagnóstico**. Hoje isso é feito à mão, uma conversa por vez, pela única pessoa da empresa — e é exatamente a etapa 3-4, o gargalo da seção 3.

7.2 Fluxo



7.3 O que entra e o que sai

| ENTRA                                                                                                                                                                                                               | SAI                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~50 respostas do Raio-X (faturamento 3 meses, lucro, retirada, horas de atendimento, ociosidade, leads/mês, conversão percebida, etapa de maior perda, 5 objeções, ticket, equipe, programas de acompanhamento) [D] | <b>Para o lead:</b> R\$/hora real · receita ociosa mensal · balde furado em R\$ · gargalo mais provável · 1 próximo passo                                           |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>Para o fundador:</b> 3 hipóteses de gargalo · 5 perguntas para a call · objeção mais provável · oferta e parcelamento recomendados · sinais de alerta (anti-ICP) |
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>Para o sistema:</b> score 0-100 · persona A/B/C · origem · etapa · timestamp                                                                                     |

7.4 Ferramentas

| CAMADA        | FERRAMENTA                             | SITUAÇÃO            |
|---------------|----------------------------------------|---------------------|
| Captura       | Google Forms                           | Já existe [D]       |
| Armazenamento | Google Sheets                          | Já existe [D]       |
| Orquestração  | n8n                                    | Já existe [D]       |
| Inteligência  | API do Claude                          | A contratar         |
| Agendamento   | Calendly                               | Já disponível       |
| Mensageria    | WhatsApp Business / e-mail             | Já existe [D]       |
| CRM           | Trello / Notion / planilha estruturada | A definir na fase 1 |

**Só uma peça nova em toda a arquitetura.** Todo o resto já está pago e ligado — este é o principal motivo pelo qual esta automação, e não outra, foi escolhida.

7.5 Tempo economizado e custo

| ITEM                            | HOJE          | DEPOIS                     | BASE DE CÁLCULO                                      |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Qualificação + preparo por lead | 45-60 min [P] | ~10 min (revisar o dossiê) | Estimativa a validar na auditoria de agenda (fase 1) |
| A 29 leads/mês [P]              | ~24-29 h/mês  | ~5 h/mês                   | <b>~20-24 h/mês devolvidas ao fundador</b>           |

| CUSTO MENSAL                         | VALOR                       |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| n8n (nuvem ou self-host)             | ~R\$ 120 [P]                |
| API do Claude neste volume           | < R\$ 100 [P]               |
| Calendly / Forms / Sheets / WhatsApp | Já pagos                    |
| <b>Total marginal</b>                | <b>~R\$ 200-300/mês [P]</b> |

Contra um custo de oportunidade de  $\approx$  **R\$ 44 mil/ano por ponto percentual** de conversão na etapa proposta  $\rightarrow$  matrícula. A automação se paga se mover a agulha em qualquer casa decimal — mas o ganho principal declarado aqui é **tempo do fundador**, não conversão, porque tempo é o recurso comprovadamente escasso e conversão ainda é hipótese.

7.6 Riscos e mitigações

| RISCO                                                                                 | MITIGAÇÃO                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A IA calcular ou interpretar errado e enviar um diagnóstico financeiro furado ao lead | <b>Nos primeiros 30 dias, nenhuma devolutiva sai sem aprovação humana.</b> Só depois libera-se envio direto, e ainda assim com amostragem semanal                               |
| Devolutiva parecer venda disfarçada e queimar confiança                               | Regra dura no prompt de análise: a devolutiva <b>não</b> menciona produto, preço ou turma. O próximo passo é uma conversa, não uma compra                                       |
| LGPD                                                                                  | Consentimento explícito no formulário, finalidade declarada, minimização de campos, política de retenção, canal de exclusão. Sem lista comprada, sem disparo indiscriminado [D] |
| Sobre-automatização matando o toque humano em produto de R\$ 60k                      | A automação prepara e organiza; <b>a conversa continua sendo 100% humana.</b> Nada substitui a sessão de diagnóstico                                                            |
| Dependência de dado autodeclarado (o médico chuta o próprio faturamento)              | A devolutiva declara explicitamente: "estimativa baseada nos números que você informou". Isso <b>umenta</b> a credibilidade em vez de reduzir                                   |
| Fluxo quebrar em silêncio                                                             | Alerta de falha no n8n + conferência semanal de volume esperado $\times$ processado                                                                                             |

8. Painel de indicadores

Sete KPIs. Um por etapa do funil, mais o indicador de vazamento.

| # | KPI                                                         | META (DIA 90) | FREQUÊNCIA | POR QUE ESTE E NÃO OUTRO                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Leads novos/semana, <b>por origem</b>                       | $\geq 7$      | Semanal    | Sem origem, não se sabe o que desligar                                       |
| 2 | Mediana do tempo até a 1ª resposta                          | $< 4$ h úteis | Semanal    | Maior alavanca isolada de conversão em alto ticket                           |
| 3 | Taxa lead $\rightarrow$ Raio-X respondido                   | $\geq 40\%$   | Quinzenal  | Mede se o convite ao diagnóstico convence                                    |
| 4 | <b>Taxa Raio-X <math>\rightarrow</math> sessão agendada</b> | $\geq 30\%$   | Quinzenal  | <b>É o gargalo. É o KPI mais importante do painel</b>                        |
| 5 | Taxa sessão $\rightarrow$ proposta                          | $\geq 70\%$   | Mensal     | Mede a qualidade da qualificação a montante                                  |
| 6 | Taxa proposta $\rightarrow$ matrícula                       | $\geq 20\%$   | Mensal     | Mede oferta, preço e prova social                                            |
| 7 | Leads sem nenhum toque há $> 30$ dias                       | <b>0</b>      | Semanal    | O indicador do balde furado. Se este for $> 0$ , os outros seis não importam |

**Faturamento não está no painel de propósito.** Faturamento é resultado, não KPI de decisão — a própria WinDoc já ensina essa distinção no Tratado de KPIs ("métrica de vaidade  $\times$  KPI de decisão"). [D] Gerenciam-se os sete acima; o faturamento é a consequência deles.

---

## 9. Riscos, ética e o que pode dar errado

---

| RISCO                                            | PROBABILIDADE | IMPACTO                                  | MITIGAÇÃO                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>O fundador não sustenta o registro no CRM</b> | <b>Alta</b>   | Fatal — sem registro, todo o plano morre | Reduzir a 5 campos. Registro no fim de cada conversa, nunca em lote. Se em 14 dias não pegar, o problema é a ferramenta: simplificar mais   |
| Oferta de entrada canibalizar a mentoria         | Média         | Alto                                     | Preço e escopo desenhados como <b>degrau</b> , não substituto: o Sprint entrega execução de 21 dias, não os 4 pilares nem a imersão         |
| A agenda clínica atropelar o plano               | <b>Alta</b>   | Alto                                     | Bloquear 2 janelas fixas/semana de "trabalho na empresa". Se não estiver no calendário, não vai acontecer                                   |
| Publicidade médica (CFM)                         | Baixa         | Alto                                     | Nenhuma promessa clínica. Todo case com disclaimer de que resultado não é promessa — regra já praticada nos documentos internos [D]         |
| LGPD em dados de leads médicos                   | Média         | Alto                                     | Consentimento, finalidade, minimização, retenção e canal de exclusão. Dados de pacientes do Instituto Vitalle <b>não entram</b> neste funil |
| Prova social frágil no início                    | Média         | Médio                                    | Começar pelos cases que já existem, com número real e autorização. Nunca inflar                                                             |
| Confundir estimativa com resultado no marketing  | Média         | <b>Fatal para a marca</b>                | Nenhum número [P] ou [E] deste documento pode ir para conteúdo ou proposta comercial                                                        |

### O maior risco de todos

Este plano falha se for tratado como mais uma lista de tarefas. As fases 1 e 2 exigem **~4 horas por semana de trabalho não clínico e não criativo** — o tipo de trabalho que o fundador mais adia porque não dá dopamina e não aparece no Instagram. A contramedida não é motivação: é **evidência semanal**, exatamente o mecanismo que a WinDoc já cobra dos mentorados no Sprint de 21 Dias. Aplicar a si mesmo o que se cobra do cliente.

---

10. O que eu não consegui responder — e qual dado destravaria cada resposta

| PERGUNTA EM ABERTO                                              | POR QUE NÃO CONSEGUI RESPONDER                                           | DADO QUE DESTRAVA                                                    | QUANDO ESTARÁ DISPONÍVEL  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Qual é a taxa real de conversão de cada etapa?                  | Nenhuma etapa é medida hoje                                              | CRM com 8 etapas + 90 dias de operação                               | Dia 90                    |
| O gargalo é mesmo qualificação, ou é a oferta?                  | As duas hipóteses explicam os mesmos sintomas                            | Comparar conversão antes e depois do lançamento da oferta de entrada | Dia 60-90                 |
| Quanto custa adquirir um aluno de R\$ 60k?                      | Sem atribuição de origem nem registro de esforço                         | Campo de origem + horas gastas por lead                              | Dia 90                    |
| Qual o preço certo da oferta de entrada?                        | Estimei R\$ 1,9k-4,9k sem qualquer teste                                 | 10 entrevistas de precificação com leads reais                       | Dia 30                    |
| Quantas turmas por ano o fundador aguenta sem perder qualidade? | Não há auditoria de capacidade                                           | Auditoria de agenda de 2 semanas + carga real da turma 1             | Dia 30                    |
| A persona A vira persona B com o tempo?                         | Exige acompanhamento de coorte                                           | Coorte da oferta de entrada acompanhada por 12-18 meses              | 2027                      |
| Tráfego pago funciona para este ICP?                            | Sem funil medido, o CAC seria calculado sobre uma conversão desconhecida | Todas as taxas do funil conhecidas                                   | Dia 90 — decidir só então |
| Qual conteúdo precede uma matrícula?                            | Sem atribuição de primeiro e último toque                                | Pergunta "como você chegou até aqui?" no Raio-X                      | Dia 30                    |

**Nota final da IA.** A conclusão mais desconfortável desta análise é também a mais acionável: a WinDoc já sabe resolver o problema da WinDoc. O diagnóstico de balde furado, o funil sem medição, a secretária que atende mas não converte, a gestão por sensação e a centralização no dono são exatamente os cinco temas que a escola ensina. O que falta não é conhecimento — é aplicar internamente o método que já está escrito, documentado e sendo vendido. Feito isso, a empresa deixa de ter um case: ela **vira** o case.

# Anexo — plano de execução de 90 dias

plano-de-acao.md

Desdobramento operacional da seção 6 de resposta.md. Aqui não há análise: só o que fazer, quando, com que evidência e qual número olhar. **Início:** segunda-feira, 14/09/2026 · **Revisão dos 90 dias:** sexta-feira, 11/12/2026

## Regra de ouro deste plano

**Orçamento: 4 horas por semana de trabalho não clínico e não criativo.**

É o tipo de trabalho que não dá dopamina e não aparece no Instagram — por isso é o primeiro a ser adiado. Duas travas, as mesmas que o Sprint de 21 Dias cobra dos mentorados:

- Bloco fixo no calendário.** Duas janelas de 2h/semana. Se não está no calendário, não vai acontecer. Sugestão: terça 7h–9h e sexta 7h–9h (antes do consultório abrir).
- Evidência semanal, não motivação.** Toda sexta, preencher o painel da seção final. Zero também é resultado — o que não pode é campo em branco.

**Sequenciamento inegociável:** medir → corrigir → automatizar. Nesta ordem. Automatizar um processo que ainda não existe produz caos mais rápido.

## Calendário-mestre

| FASE             | SEMANAS | PERÍODO       | OBJETIVO                      |
|------------------|---------|---------------|-------------------------------|
| 1 — Instrumentar | 1–4     | 14/09 → 11/10 | Parar de decidir por sensação |
| 2 — Converter    | 5–8     | 12/10 → 08/11 | Consertar o balde             |
| 3 — Automatizar  | 9–13    | 09/11 → 13/12 | Devolver tempo e escalar      |

**Feriados na janela:** 12/10 (segunda), 02/11 (segunda), 20/11 (sexta), 25/12. Dois deles caem exatamente em início de semana — as semanas 5 e 8 já estão dimensionadas com carga menor por causa disso.

## FASE 1 — INSTRUMENTAR

**Semanas 1 a 4 · 14/09 a 11/10 · ~4h/semana**

**Objetivo da fase:** ao final, existir um número real para cada etapa do funil. **Critério de conclusão:** 8 etapas nomeadas, 100% dos leads novos registrados, tempo de primeira resposta conhecido, e a decisão sobre a oferta de entrada tomada.

## Semana 1 · 14/09 – 20/09 · Criar o instrumento

| #   | AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   | TEMPO  | ENTREGÁVEL                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 1.1 | Criar o CRM mínimo com <b>8 colunas</b> (Novo · Contatado · Raio-X enviado · Raio-X respondido · Sessão agendada · Sessão feita · Proposta · Fechado/Perdido). Trello, Notion ou planilha — a ferramenta é irrelevante, o registro não | 60 min | Quadro no ar                 |
| 1.2 | Definir os <b>5 campos obrigatórios</b> por lead: nome · origem (post, story, DM, indicação, busca, evento) · especialidade · persona (A/B/C) · data de entrada                                                                        | 20 min | Template do card             |
| 1.3 | Escrever a regra de <b>SLA: primeira resposta em até 4h úteis</b> . Configurar alerta no celular                                                                                                                                       | 20 min | Regra escrita + alerta ativo |
| 1.4 | Escrever <b>3 scripts</b> e salvar como resposta rápida no Instagram e no WhatsApp Business                                                                                                                                            | 90 min | 3 scripts salvos             |
| 1.5 | Bloquear as duas janelas semanais no Google Calendar até 13/12                                                                                                                                                                         | 10 min | Calendário bloqueado         |

**Os 3 scripts (1.4):** - **Boas-vindas** — novo seguidor médico: *"Oi [nome], que bom ter você aqui. Vi que você é médico(a). Me conta: qual especialidade e qual é o seu maior travamento hoje — convênio, precificação ou posicionamento?"* - **Qualificação** — quem demonstrou interesse: entender momento, faturamento aproximado, se é dono do próprio consultório, e o que aconteceria se nada mudasse em 12 meses. - **Convite ao Raio-X** — não vender: *"Antes de eu falar qualquer coisa sobre a WinDoc, quero entender seus números. Responde esse diagnóstico — leva ~15 min e eu te devolvo uma leitura da sua operação, independente de a gente trabalhar junto ou não."*

**Indicador da semana:** quadro no ar com os 5 campos. Binário: sim ou não.

## Semana 2 · 21/09 – 27/09 · Povoar a base

| #   | AÇÃO                                                                                                                                                   | TEMPO   | ENTREGÁVEL           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 2.1 | Varrer DM do Instagram, WhatsApp, e-mail e a planilha do n8n dos últimos <b>90 dias</b> . Cadastrar cada pessoa real no CRM, na etapa em que ela parou | 120 min | Base inicial povoada |
| 2.2 | Marcar quem está <b>sem nenhum toque há mais de 30 dias</b> — este é o número do balde furado                                                          | 20 min  | Lista de resgate     |
| 2.3 | Ligar a cadência de follow-up <b>D+2 / D+5 / D+12 / D+30</b> como tarefas recorrentes no CRM                                                           | 40 min  | Cadência ativa       |
| 2.4 | Escrever os 4 textos da cadência (curtos, sem cobrança, um ângulo novo em cada)                                                                        | 60 min  | 4 templates          |

**Indicador da semana:** nº de leads recuperados + nº de leads sem toque há >30 dias. Esse segundo número vai doer. É para doer — é o custo invisível medido pela primeira vez.

## Semana 3 · 28/09 – 04/10 · Fazer à mão o que depois será automático

| #   | AÇÃO                                                                                                                                                                             | TEMPO   | ENTREGÁVEL           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 3.1 | Enviar o Raio-X Estratégico para <b>5 leads</b> da base recuperada                                                                                                               | 30 min  | 5 envios registrados |
| 3.2 | Escrever <b>à mão</b> a devolutiva de 1 página para cada um que responder: R\$/hora real · receita ociosa mensal · balde furado em R\$ · gargalo mais provável · 1 próximo passo | 150 min | 5 devolutivas        |
| 3.3 | Anotar quanto tempo levou cada uma e o que se repetiu entre elas                                                                                                                 | 20 min  | Notas de padrão      |

**Por que fazer à mão:** estas 5 devolutivas *são* a especificação da automação da Fase 3. Só se automatiza bem o que já se fez à mão. Não pule esta semana.

**Regra dura:** a devolutiva **não menciona produto, preço nem turma**. O próximo passo oferecido é uma conversa, nunca uma compra.

**Indicador da semana:** taxa de resposta ao Raio-X e taxa devolutiva → conversa aceita.

## Semana 4 · 05/10 – 11/10 · Auditar e decidir

| #   | AÇÃO                                                                                                                                                                   | TEMPO   | ENTREGÁVEL                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| 4.1 | Auditoria de agenda: somar as horas das últimas 2 semanas gastas em tarefa comercial manual (responder DM, qualificar, preparar call, follow-up)                       | 40 min  | Baseline de horas             |
| 4.2 | <b>10 conversas de precificação</b> com leads reais sobre a oferta de entrada: o que ele pagaria por 21 dias de execução acompanhada, e o que precisaria estar incluso | 150 min | Notas das 10                  |
| 4.3 | <b>Decidir</b> escopo, formato, número de vagas e preço da oferta de entrada                                                                                           | 40 min  | Documento de oferta, 1 página |
| 4.4 | Primeira leitura do painel (fim da Fase 1)                                                                                                                             | 20 min  | Painel preenchido             |

**A decisão 4.3 é a mais importante dos 90 dias.** Hipótese de partida: Sprint de 21 Dias produtizado, R\$ 1.900–4.900, turma fechada, entrega majoritariamente já construída. As 10 conversas existem para **derrubar ou confirmar** essa faixa — não para validá-la por educação. Se ninguém pagaria, o preço está errado e é melhor descobrir agora.

### ✓ Portão da Fase 1 — não avance sem isto

- [ ] 8 etapas nomeadas e no ar
- [ ] 100% dos leads novos das últimas 4 semanas registrados
- [ ] Tempo mediano de primeira resposta **conhecido** (não precisa estar bom ainda)
- [ ] 5 devolutivas escritas à mão
- [ ] Oferta de entrada decidida: escopo, vagas e preço no papel

# FASE 2 — CONVERTER

Semanas 5 a 8 · 12/10 a 08/11 · ~4h/semana

**Objetivo da fase:** corrigir o balde e provar que a conversão sobe sem mais audiência. **Critério de conclusão:** oferta de entrada vendida em turma piloto, 3 cases prontos, sessão de diagnóstico padronizada.

Semana 5 · 12/10 – 18/10 · Preparar o lançamento (*feriado 12/10 — carga reduzida*)

| #   | AÇÃO                                                                                                                                                                                      | TEMPO   | ENTREGÁVEL        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 5.1 | Escrever a página/roteiro da oferta de entrada: para quem é, para quem <b>não</b> é, o que acontece nos 21 dias, o que o médico entrega de volta, vagas, preço                            | 120 min | Roteiro de oferta |
| 5.2 | Definir a lista de convite: quem da base recebe primeiro (quem respondeu o Raio-X vem antes de quem só segue)                                                                             | 30 min  | Lista priorizada  |
| 5.3 | Padronizar a <b>sessão de diagnóstico</b> em roteiro de 1 página: abertura, leitura dos números dele, 3 perguntas de gargalo, devolutiva, próximo passo definido <b>antes</b> de encerrar | 60 min  | Roteiro de sessão |

Semana 6 · 19/10 – 25/10 · Abrir

| #   | AÇÃO                                                                                      | TEMPO   | ENTREGÁVEL          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 6.1 | Abrir a oferta de entrada para a lista priorizada — <b>antes</b> de qualquer post público | 60 min  | Convites enviados   |
| 6.2 | Abrir publicamente nos dois perfis, com CTA para o Raio-X (não para a compra direta)      | 60 min  | Abertura no ar      |
| 6.3 | Rodar as sessões de diagnóstico geradas, usando o roteiro da 5.3                          | 120 min | Sessões registradas |

**Indicador da semana:** nº de matrículas na turma piloto + taxa convite → matrícula.

Semana 7 · 26/10 – 01/11 · Provar

| #   | AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   | TEMPO   | ENTREGÁVEL           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 7.1 | Produzir <b>3 cases estruturados</b> , um por persona, com autorização por escrito. Formato: ponto de partida (número) → o que foi mudado (mecanismo, não motivação) → resultado (número + disclaimer de que resultado não é promessa) | 150 min | 3 one-pagers         |
| 7.2 | Gravar 3 depoimentos curtos em vídeo (60-90s cada)                                                                                                                                                                                     | 60 min  | 3 vídeos             |
| 7.3 | Criar o <b>dossiê de 1 página</b> que o lead leva para cônjuge ou sócio                                                                                                                                                                | 60 min  | Template de proposta |

O dossiê da 7.3 ataca a objeção "*vou pensar / falar em casa*", que não é indecisão — é falta de material para o decisor que não estava na call.

## Semana 8 · 02/11 – 08/11 · Ler os números (*feriado 02/11 — carga reduzida*)

| #   | AÇÃO                                                                                                      | TEMPO  | ENTREGÁVEL   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 8.1 | <b>Primeira leitura formal do painel completo</b> com 8 semanas de dado real                              | 60 min | Painel + ata |
| 8.2 | Identificar a objeção mais registrada no campo "motivo da perda" e ajustar script e conteúdo em cima dela | 60 min | Script v2    |
| 8.3 | Rodar a turma piloto da oferta de entrada                                                                 | —      | Em andamento |

### ✓ Portão da Fase 2 — não avance sem isto

- [ ] Turma piloto da oferta de entrada vendida (mesmo que pequena)
- [ ] 3 cases estruturados prontos e em uso nas propostas
- [ ] Sessão de diagnóstico com roteiro fixo
- [ ] Painel com dado real de 8 semanas
- [ ] Objeção nº 1 identificada por registro, não por memória

## FASE 3 — AUTOMATIZAR

### Semanas 9 a 13 · 09/11 a 13/12 · ~4h/semana

**Objetivo da fase:** transformar as 5 devolutivas manuais da semana 3 em processo. **Critério de conclusão:** motor rodando, base reativada, decisão de 90 dias tomada com dado.

## Semana 9 · 09/11 – 15/11 · Especificar o motor

| #   | AÇÃO                                                                                                                               | TEMPO   | ENTREGÁVEL          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 9.1 | Escrever o <b>prompt de análise</b> que a IA vai rodar sobre cada Raio-X, usando as 5 devolutivas manuais como gabarito            | 120 min | Prompt de análise   |
| 9.2 | Definir os 4 artefatos de saída: score 0-100 + persona · devolutiva para o lead · dossiê pré-call para você · linha no CRM         | 40 min  | Especificação       |
| 9.3 | Definir as faixas de roteamento: ≥70 agenda sessão · 40-69 nutrição para a oferta de entrada · <40 conteúdo, sem contato comercial | 20 min  | Regra de roteamento |

Semana 10 · 16/11 – 22/11 · Construir (*feriado 20/11*)

| #    | AÇÃO                                                             | TEMPO   | ENTREGÁVEL             |
|------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 10.1 | Montar o fluxo no n8n: Forms → Sheets → gatilho → API → 4 saídas | 180 min | Fluxo em rascunho      |
| 10.2 | Ligar o Calendly na saída de score $\geq 70$                     | 30 min  | Agendamento automático |

**Trava obrigatória:** nos primeiros 30 dias, **nenhuma devolutiva sai sem sua aprovação**. A automação prepara; você aprova. Só depois libera-se envio direto, e ainda com amostragem semanal.

Semana 11 · 23/11 – 29/11 · Testar em produção

| #    | AÇÃO                                                                                 | TEMPO  | ENTREGÁVEL                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 11.1 | Rodar o motor com 10 leads reais, aprovando cada devolutiva antes do envio           | 90 min | 10 devolutivas assistidas |
| 11.2 | Corrigir o prompt onde a IA errou cálculo, tom ou hipótese de gargalo                | 90 min | Prompt v2                 |
| 11.3 | Ligar alerta de falha do fluxo + conferência semanal de volume esperado × processado | 30 min | Monitoramento ativo       |

Semana 12 · 30/11 – 06/12 · Reativar a base

| #    | AÇÃO                                                                                                                              | TEMPO  | ENTREGÁVEL        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 12.1 | Campanha de reativação: enviar o Raio-X para toda a lista de resgate da semana 2, usando a devolutiva como isca                   | 90 min | Lista trabalhada  |
| 12.2 | Ligar a régua de nutrição de 4 mensagens para score 40–69                                                                         | 90 min | Régua ativa       |
| 12.3 | Iniciar a migração da audiência médica de @dr.fernandojorge para @windoc.oficial (cross-promotion estruturada, não anúncio único) | 30 min | Plano de migração |

Semana 13 · 07/12 – 13/12 · A revisão dos 90 dias

| #    | AÇÃO                                                                                                | TEMPO  | ENTREGÁVEL            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 13.1 | Reescrever a tabela de premissas: trocar cada [P] e [E] por [D] com o número real                   | 60 min | Premissas atualizadas |
| 13.2 | Calcular as 4 taxas de conversão reais do funil                                                     | 40 min | Funil medido          |
| 13.3 | <b>Decidir com dado:</b> vale tráfego pago? Vale contratar comercial? Quantas turmas o ano suporta? | 60 min | Documento de decisão  |
| 13.4 | Planejar o trimestre seguinte a partir do gargalo <b>real</b> , não do suposto                      | 60 min | Plano Q1/2027         |

**Alerta de calendário.** A semana 13 cai em plena zona morta de fim de ano. Duas consequências práticas: (1) a turma piloto da oferta de entrada precisa **fechar até a primeira semana de dezembro** ou escorrega para fevereiro; (2) a turma cheia da mentoria de R\$ 60 mil não deve ser lançada em dezembro — o lançamento natural, com o funil já medido e os cases prontos, é **fevereiro/março de 2027**.

### O painel semanal — preencher toda sexta

Mesmo formato que a WinDoc cobra dos mentorados no Sprint. Aplicado a você.

PLANO WINDOC – SEMANA \_\_/13 | Data: \_\_/\_\_/\_\_  
Leads novos: \_\_ (origens: \_\_)  
1ª resposta – mediana: \_\_ h  
Raio-X enviados: \_\_ | respondidos: \_\_  
Sessões agendadas: \_\_ | realizadas: \_\_  
Propostas: \_\_ | fechadas: \_\_  
Leads sem toque há +30 dias: \_\_  
Horas em tarefa comercial manual: \_\_  
Ações da semana: \_\_ / \_\_ concluídas  
Maior dificuldade: \_\_  
Prioridade da próxima semana: \_\_

### Os 7 indicadores e suas metas no dia 90

| # | INDICADOR                          | META         | FREQUÊNCIA |
|---|------------------------------------|--------------|------------|
| 1 | Leads novos/semana, por origem     | ≥ 7          | Semanal    |
| 2 | Mediana do tempo até a 1ª resposta | < 4h úteis   | Semanal    |
| 3 | Lead → Raio-X respondido           | ≥ 40%        | Quinzenal  |
| 4 | <b>Raio-X → sessão agendada</b>    | <b>≥ 30%</b> | Quinzenal  |
| 5 | Sessão → proposta                  | ≥ 70%        | Mensal     |
| 6 | Proposta → matrícula               | ≥ 20%        | Mensal     |
| 7 | Leads sem nenhum toque há >30 dias | <b>0</b>     | Semanal    |

O indicador 4 é o gargalo. Se só houver tempo para olhar um número, é esse. Faturamento fica fora do painel de propósito: é resultado, não KPI de decisão.

## O que NÃO fazer nestes 90 dias

| NÃO FAÇA                             | POR QUÊ                                                                                       | QUANDO RECONSIDERAR                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Comprar tráfego pago                 | O CAC seria calculado sobre uma conversão desconhecida. É comprar volume para um balde furado | Semana 13, com as 4 taxas medidas          |
| Contratar comercial                  | Transferir um processo indefinido para outra pessoa multiplica a indefinição                  | Depois que o processo existir e for medido |
| Aumentar o volume de conteúdo        | O topo de funil já é 4-7x maior que o necessário                                              | Nunca como resposta a este problema        |
| Colocar a plataforma LMS em produção | Alto esforço de engenharia, zero impacto no gargalo. Área de membros entrega, não vende       | Quando houver volume que justifique        |
| Lançar a mentoria cheia em dezembro  | Zona morta de decisão no fim do ano                                                           | Fev/mar 2027, com cases e funil medidos    |
| Automatizar antes da semana 9        | Automatizar caos produz caos mais rápido                                                      | Só depois das 5 devolutivas manuais        |

## O risco número um deste plano

Não é a estratégia estar errada. É o registro no CRM não pegar.

Se em 14 dias o hábito não colar, **o problema é a ferramenta, não a disciplina** — simplifique mais: menos campos, registro no fim de cada conversa, nunca em lote. Um CRM de 5 campos que é preenchido vale infinitamente mais do que um CRM completo que fica vazio.